



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

PROGRAM KERJA
NEONATAL INTENSIVE CARE UNIT
(NICU)

TAHUN 2026

Jl. Raya Surabaya - Malang No. KM 54, Sukorejo - Pasuruan

Telp. 0343 - 6745000

Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com



**PROGRAM KERJA NEONATAL INTENSIVE CARE UNIT
RSPH SUKOREJO TAHUN 2026**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar belakang

Neonatal Intensive Care Unit (NICU) merupakan unit perawatan intensif yang ditujukan untuk bayi baru lahir dengan kondisi medis yang memerlukan pemantauan ketat dan intervensi khusus, seperti prematuritas, gangguan pernapasan, infeksi, atau kelainan bawaan. Kualitas pelayanan di NICU sangat menentukan derajat kesehatan dan keselamatan bayi pada masa awal kehidupan, yang merupakan periode kritis dalam tumbuh kembang anak.

Dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan neonatal, diperlukan suatu program kerja yang terstruktur, komprehensif, dan berkesinambungan. Program kerja NICU disusun untuk memastikan tersedianya sumber daya manusia yang kompeten, sarana dan prasarana yang memadai, serta penerapan prosedur klinis yang sesuai standar. Selain itu, program ini mendukung pencapaian indikator kesehatan nasional, seperti penurunan angka kematian neonatal dan peningkatan kualitas hidup bayi berisiko tinggi. Penanganan optimal pada periode neonatal sangat menentukan keberlangsungan hidup dan kualitas tumbuh kembang anak. Tingginya kasus prematuritas, BBLR (berat badan lahir rendah), asfiksia, sepsis, serta gangguan pernapasan menuntut NICU untuk memiliki standar pelayanan yang baik, tenaga kesehatan kompeten, dan fasilitas yang memadai.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang neonatologi menuntut fasilitas NICU untuk terus melakukan pembaruan dan peningkatan pelayanan. Dengan demikian, penyusunan program kerja NICU menjadi langkah strategis dalam mewujudkan pelayanan neonatal yang aman, efektif, responsif, dan berorientasi pada keselamatan pasien.

Untuk itu, diperlukan program kerja NICU yang sistematis dan berkesinambungan dengan tujuan meningkatkan mutu pelayanan, menurunkan risiko komplikasi, mencapai standar keselamatan pasien, serta mendukung pencapaian indikator kesehatan nasional.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang - Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
3. Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2020 tentang Kalsifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/47104/2024 tentang Instrumen Survei Akreditasi Rumah Sakit;



8. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor : 635.1/DPM/I-KEP/DIR/XII/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Program Kerja NICU disusun sebagai pedoman operasional dalam pedoman operasional agar pelayanan NICU berjalan terencana, terstandar, aman, dan berkualitas, sehingga setiap bayi dengan kondisi kritis atau berisiko tinggi mendapat penanganan optimal.

2. Tujuan Umum

Menyelenggarakan pelayanan intensive care yang komprehensif, efektif, dan berkesinambungan untuk bayi baru lahir yang membutuhkan perawatan khusus. Menurunkan angka mortalitas dan morbiditas neonatal melalui tata kelola pelayanan yang bermutu.

3. Tujuan Khusus

1. Menjamin terselenggaranya pelayanan NICU sesuai standar operasional prosedur (SOP)
2. Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan melalui pelatihan rutin.
3. Menyediakan sarana prasarana sesuai kebutuhan klinis.
4. Memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan kasus secara akurat.
5. Meningkatkan keterlibatan keluarga dalam proses perawatan (*family centered care*).
6. Meminimalkan kejadian infeksi nosokomial melalui penerapan program pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI).



BAB II GAMBARAN UMUM

2.1 Visi

Menurunkan angka kematian dan meningkatkan derajat Kesehatan bayi baru lahir

2.2. Misi

1. Berperan serta dalam pengembangan pelayanan kesehatan khususnya pelayanan *Neonatal Intensive Care*
2. Berperan serta dalam menurunkan angka kematian bayi
3. Bekerjasama secara tim dalam memberikan Asuhan Medis, Asuhan Keperawatan pada kasus perinatal.

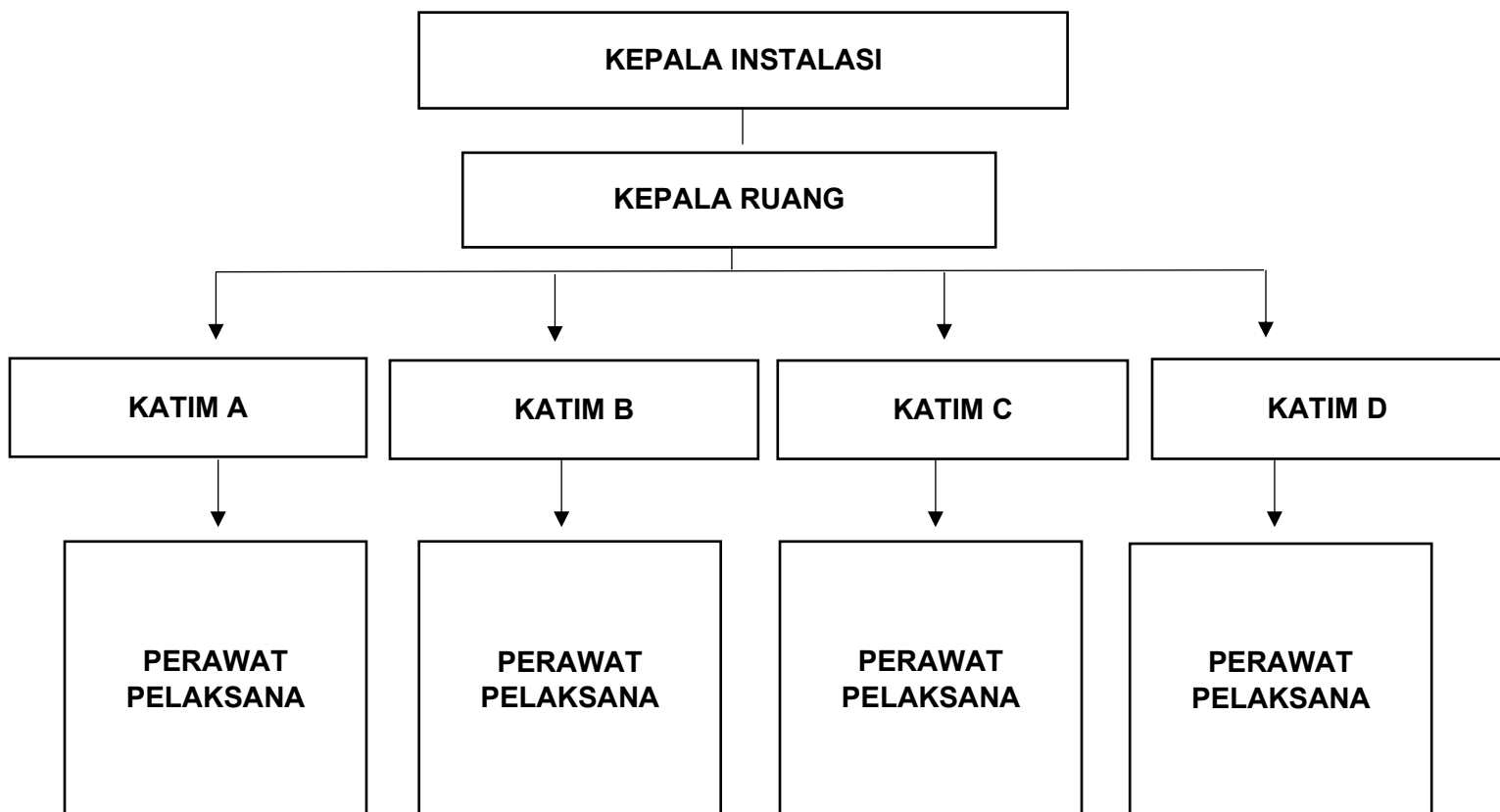
2.3. Motto

Aman, Tepat, Cepat dan Akurat

2.4. 7 Nilai Budi Utama

Jujur, tanggung jawab, visioner, disiplin, kerjasama, adil, peduli

2.5. SOTK



2.6 Kualifikasi staf NICU

1. Mempunyai lisensi dalam melakukan praktik keperawatan
2. Memiliki sertifikat keperawatan khusus untuk lingkungan perawatan NICU
3. Mampu melakukan pendekatan perawatan yang berpusat pada keluarga, tidak hanya terbatas pada perawatan skin-to-skin, dukungan laktasi dan menyusui, dan keterlibatan keluarga dalam perawatan bayi.
4. Bertanggung jawab atas aktivitas rawat inap di NICU
5. Mampu berkoordinasi dengan masing-masing layanan perawatan neonatal, anak, dan obstetric, jika diperlukan
6. Mampu memberikan pengawasan terhadap prosedur beresiko rendah dan beresiko tinggi sesuai dengan perawatan yang diberika di NICU
- 7.



BAB III.
KEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN

3.1 Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan

Tabel 3.1 Tabel Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan

No	KEGIATAN POKOK	RINCIAN KEGIATAN
1.	Meningkatkan SDM NICU	a. Menghitung Kebutuhan SDM b. Melaksanakan Orientasi khusus bagi staf baru c. Melaksanakan diklat terkait akreditasi (mengikuti SDM) d. Melaksanakan Diklat NICU (mengirimkan 1-2 staf)
2	Melaksanakan Asuhan pasien-pasien NICU	a. Melakukan personal higien b. Melakukan asuhan pasien c. Melakukan tindakan kegawatan di NICU d. Melakukan pemberdayaan keluarag pasien e. Melakukan pelayanan bio, psiko, sosio, kultural dan spiritual
3	Pengembangan Pelayanan	a. Adanya ruang tunggu khusus keluarga pasien NICU a. Penambahan aksesoris foto dan studio foto baby newborn
4	Melaksanakan MFK-K3	a. Melaksanakan Pemeliharaan alat (incubator, ventilator, infan warmer, alat monitoring) b. Kalibrasi berkala c. Pengadaan alat unit d. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 1) Melakukan pencegahan/mitigasi risiko terjadinya Kecelakaan kerja (paparan, paparan, tusukan, terpeleset, jatuh, kesetrum) 2) Melakukan MCU
5	Melaksanakan Pengukuran Indikator Mutu yang diukur di NICU (PMKP)	a. Monitoring indicator mutu (NIM) 1) Kepatuhan Identifikasi Pasien 2) Kepatuhan Kebersihan Tangan 3) Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Jatuh 4) Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri 5) Kepatuhan Waktu Visite Dokter ≤ 14:00 WIB 6) Kepatuhan perawat terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR b. Monitoring indicator mutu Prioritas Unit 1) Kejadian tidak dilakukan IMD pada bayi baru lahir 2) Kepatuhan Petugas dalam melakukan Tindakan Ventilasi Tekanan Positif (VTP) pada bayi baru lahir tanpa ada usaha napas (< 1 menit) 3) Bayi baru lahir yang mengalami sesak napas yang mendapatkan T-Piece resuscitator/ CPAP dalam waktu 2 menit



		4) Bayi baru lahir hidup stabil berat lahir 1500-2000 gr yang mendapatkan perawatan metode kangguru (PMK) minimal 1 jam per hari 5) Kepatuhan DPJP dalam pemberian antibiotic pada BBL infeksi 6) Kejadian Kematian Bayi di Rumah Sakit 7) Kemampuan menangani BBLR 1500 gr – 2500 gr	
6	Melaksanakan Program SKP	a. Penerapan SKP 1: Identifikasi pasien minimal 2 identitas. b. Penerapan SKP 2: Komunikasi efektif (S-BAR, read back untuk prosedur tertentu). c. Penerapan SKP 3: Pemberian obat kontras yang aman. d. SKP 4: Prosedur benar, pasien benar, alat benar sesuai SOP. e. SKP 5: Pencegahan infeksi terkait prosedur (terutama Inkubator). f. SKP 6: Pencegahan risiko jatuh pada pasien mobilisasi terbatas. g. Pelaporan insiden keselamatan pasien (KTD, KNC, KTC, KPC). h. Evaluasi berkala penerapan SKP dengan PMKP & Komite Mutu	
7	Melaksanakan program PPI di NICU	1) Melaksanakan Kewaspadaan standard a) Hand Hygiene b) Alat Pelindung diri c) Pemilahan sampah d) Kejadian Plebitis e) Kejadian Bundle ISK f) Presentase Bundle ISK g) Kejadian Bundle VAP h) Kejadian Dekubitus 2) Melaksanakan Kewaspadaan Transmisi	
8	Melaksanakan program PKRS	1) Melaksanakan KIE kepada pasien dan keluarga (100%) 2) Melaksanakan KIE kepada pengunjung/kelompok (8x/bl) 3) Melaksanakan KIE Kepada Masyarakat (Massa melalui radio Rs, Medsos) 4) Mengelola logistik & Media Edukasi untuk R. NICU	
9	Melaksanakan MONEV	a. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi semua program 1) Asuhan pasien 2) MFK-K3 3) PMKP 4) PPI 5) PKRS b. Melaksanakan rapat unit	

3.2. Sasaran

Tabel 3.2 Sasaran Kegiatan

NO	RINCIAN KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	JENIS	TARGET/ STANDARD	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
1	Meningkatkan SDM NICU						
	a. Menghitung Kebutuhan SDM	Memenuhi kebutuhan SDM NICU	Karu	SDM	Per bulan	Terdapat dokumen usulan kebutuhan (setelah melakukan perhitungan)	
	b. Melaksanakan Orientasi khusus bagi staf baru	Mengenalakan tugas baru kepada staf baru	Jika ada staf baru	SDM	Tergantung SDM	Terdapat Form Penilaian staf orinetasi yang telah dibuat	
	c. Membuat penilaian Kinerja staf	Mengevaluasi hasil kinerja harian staf	Semua petugas NICU	Evaluasi Kinerja	1 th 1x (data tiap bln)	Terdapat dokumen penilaian kinerja all staf (yg tdd: uraian tugas dan mutu yang diukur di unit NICU tiap hari dipantau)	
	d. Melaksanakan Diklat terkait akreditasi (mengikuti SDM)	Peningkatan kualitas SDM yang dapat meningkatkan pelayanan dan kompeten di NICU	All Staf	Internal	100%	sertifikat	
	e. Melaksanakan Diklat NICU (mengirimkan 1-2 staf ke RSSA atau RSUD dr. Soetomo)		Seluruh staff	Eksternal	100%	sertifikat	
2	Melaksanakan Asuhan pasien NICU						
	a. Melakukan Personal Higiene	Memenuhi kebutuhan dasar pasien	Seluruh pasien NICU	Internal	Setiap hari	CPPT di SIMRS	
	b. Melakukan Asuhan Pasien	Memenuhi kebutuhan asuhan pasien di ruang NICU	Seluruh pasien NICU	Internal	Setiap hari	CPPT di SIMRS	
	c. Melakukan Tindkan Kegawatan NICU	Melakukan tindkaan tindakan emergency yang	Seluruh pasien NICU	Internal	Setiap hari	CPPT di SIMRS	



		dibutuhkan oleh pasien NICU					
	d. Melakukan Pemberdayaan Keluarga Pasien	Meningkatkan pemahaman keluarga mengenai kondisi pasien	Seluruh pasien NICU	Internal	Setiap hari	CPPT di SIMRS	
	e. Melakukan Pelayanan Psiko, Sosio, Cultural, Spiritual	Memfasilitasi mengenai kebutuhan pelayanan psiko, sosio, cultural spiritual	Seluruh pasien NICU	Internal	Setiap hari	CPPT di SIMRS	
3.	Pengembangan Pelayanan						
	a. Ruang tunggu khusus keluarga pasien NICU	Kenyamanan penunggu keluarga pasien NICU	Keluarga NICU	Internal	Terpenuhi	Adanya fasilitas ruang tunggu yang nyaman khusus untuk keluarga pasien NICU	
	b. Penambahan aksesoris foto dan studio foto baby newborn	Menegmbangkan layanan dokumentasi bayi baru lahir melalui pelayanan studio foto newborn yang aman, professional, dan asesuai standart NICU	Pasien	Pengembangan	Dilakukan pada semua pasien nicu dan neonatologi	Semua pasien mendapatkan foto baby newborn	
4	Melaksanakan MFK-K3						
	a. Melaksanakan Pemeliharaan sarana NICU (Bangunan)	Memastikan lingkungan fisik ruang NICU dalam keadaan aman dan nyaman	Kabid Umum Tukang	Internal	Terpenuhi	Laporan Bulanan	
	Melaksanakan Pemeliharaan Prasarana NICU (pemeliharaan harian aldok/alkes/ Kalibrasi b. aldok/alkes	Memastikan semua failitas dan alat dalam kondisi baik	IPSRS	Internal	Kalibrasi : 1 tahun Sekali	Laporan Bulanan	
	c. Melaksanakan Penambahan alat baru	Memenuhi kebutuhan alat yang masih kurang atau belum ada	Karu ICU	Internal	Terpenuhi	Tidak ada peminjaman alat ke unit lain	



	d. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja a) Melakukan pencegahan/mitigasi risiko terjadinya Kecelakaan kerja (paparan, paparan, tusukan, terpeleset, terpeleset, b) Melakukan MCU	a) Mencegah terjadinya kecelakaan kerja (paparan, paparan, tusukan, terpeleset, jatuh, kesetrum) b) Menilai kondisi kesehatan staf	Seluruh Staf ICU	Internal	a) Terpenuhi	Tidak ada staf yang mengalami kecelakaan kerja a) File MCU seluruh staf	
5	Melaksanakan Pengukuran Indikator Mutu yang diukur di N I C U (PMKP)						
	a. Pengukuran Indikator Mutu Nasional (NIM) 1) Kepatuhan Identifikasi Pasien 2) Kepatuhan Kebersihan Tangan 3) Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Jatuh 4) Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri 5) Kepatuhan Waktu Visite Dokter ≤ 14:00 WIB 6) Kepatuhan perawat terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR	Terciptanya budaya keselamatan pasien di rumah sakit peningkatan akuntabilitas rumah sakit terhadap pasien dan masyarakat, menurunnya angka IKP	1. Staff ICU 2. PIC Mutu	Internal	Sesuai standart a) 100% b) 100% c) 100% d) ≥80% e) 100% 100%	1. Melakukan sosialisasi SKP tentang identifikasi pasien 2. Melakukan supervisi karu dan PPI mengenai Hand Hiygiene 6 langkah dan 5 moment 3. Melakukan supervise karu terhadap kepatuhan resiko jatuh 4. Koordinasi kepada DPJP terkait kepatuhan waktu visite 5. Melakukan supervisi penggunaan APD yang tepat	
	b. Pengukuran Inidkator Mutu Prioritas Unit: 1) Kejadian tidak dilakukan IMD pada bayi baru lahir	Terciptanya budaya keselamatan pasien di rumah sakit peningkatan akuntabilitas rumah sakit terhadap pasien dan	1. Staff ICU 1. PIC Mutu	Internal	Sesuai standart a) 0 kejadian b) 100% c) 100% d) 100% e) 100%	1. Koordinasi dengan tim dan DPJP terkait pelaksanaan penanganan pertama kegawatan neoantus	



	2) Kepatuhan Petugas dalam melakukan Tindakan Ventilasi Tekanan Positif (VTP) pada bayi baru lahir tanpa ada usaha napas (< 1 menit) 3) Bayi baru lahir yang mengalami sesak napas yang mendapatkan T-Piece resuscitator/ CPAP dalam waktu 2 menit 4) Bayi baru lahir hidup stabil berat lahir 1500-2000 gr yang mendapatkan perawatan metode kangguru (PMK) minimal 1 jam per hari 5) Kepatuhan DPJP dalam pemberian antibiotic pada BBL infeksi 6) Kejadian Kematian Bayi di Rumah Sakit 7) Kemampuan menangani BBLR 1500 gr – 2500 gr	masyarakat, menurunnya angka IKP			f) 0 kejadian 100 %	2. Sosialisasi dan supervise terkait tindakan IMD 3. Koordinasi dengan tim dan DPJP terkait penggunaan antibiotik	
6	Melaksanakan program PPI di NICU						
	1. Melaksanakan Kewaspadaan standard a) Hand Hygiene b) Alat Pelindung diri	Tidak ada infeksi yang menular dari staf ke pasien	Seluruh staf NICU	Internal	0 kejadian	Tidak ada kejadian infeksi pada pasien yang disebabkan oleh staf	



	c) Pemilahan sampah d) Kejadian Plebitis e) Kejadian Bundle ISK f) Presentase Bundle ISK g) Kejadian Bundle VAP h) Kejadian Dekubitus						
	2. Melaksanakan Kewaspadaan Transmisi	Tidak ada infeksi yang menular dari staf ke pasien	Seluruh staf NICU	Internal	0 kejadian	Tidak ada kejadian infeksi pada pasien yang disebabkan oleh staf	
7	Melaksanakan Program PKRS						
	1. Melaksanakan KIE kepada pasien dan keluarga	Meningkatkan pemahaman, keterlibatan keluarga	1) Keluarga pasien NICU 2) PIC PKRS	Internal	100%	Form Edukasi Terintegrasi	
	2. Melaksanakan KIE kepada pengunjung/kelompok (8x/bl)	Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat secara luas mengenai kesehatan	1) Keluarga pasien NICU 2) PIC PKRS	Internal	8x/bln	Form Edukasi Kelompok	
	3. Melaksanakan KIE Kepada Masyarakat (Massa melalui radio Rs, Media Sosial)	Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai berbagai macam penyakit dan pencegahannya	1) Keluarga pasien NICU 2) PIC PKRS	Internal	1 bulan sekali	Video Edukasi	
	4. Mengelola logistik & Media Edukasi untuk R. NICU	Memastikan seluruh kebutuhan pelayanan dan edukasi keluarga pasien berjalan optimal	1) Keluarga pasien NICU 2) PIC PKRS	Internal	Seminggu 2x	Adanya Video, Leaflet, Poster	
8	Melaksanakan MONEV						
	Melaksanakan Monitoring (Supervisi) dan Evaluasi semua program a) Asuhan pasien b) MFK-K3	Memastikan bahwa seluruh kegiatan berjalan sesuai rencana dan mencapai hasil yang diharapkan	Kepala Ruang	Internal	Supervisi : Setiap hari Evaluasi : 1 bulan sekali	Laporan Supervisi dan Evaluasi Kinerja	



	c) PMKP d) PPI e) PKRS f) Manrisk						
	Melaksanakan Rapat Unit	Mengkoordinasikan, mengevaluasi dan meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas di dalam satu unit kerja.	Kepala Ruang	Internal	1x/bulan	Umandok rapat unit	
	Menghadiri Rapat Koordinasi antar unit, manajemen program	Mengkoordinasikan, mengevaluasi dan meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas di dalam kinerja.	Kepala Ruang	Internal	1x/bulan	Umandok rapat koordinasi	
9	Membuat laporan						
	Membuat laporan bulanan (bulanan, tahunan)	Mendokumentasikan, mengevaluasi, dan menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan selama satu bulan.	Kepala Ruang	Internal	1x/bulan	Laporan bulanan	

3.3. Cara Melaksanakan Kegiatan

Tabel 3.3 Cara Melaksanakan Kegiatan

NO	RINCIAN KEGIATAN	CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN	METODE	MEDIA	JADWAL	BUKTI PELAKSAAN	KET
1	Meningkatkan SDM NICU						
	a) Menghitung Kebutuhan SDM	1. Melakukan perhitungan sesuai rumus 2. Membandingkan kenyataan / existing dengan perhitungan	Lembar perhitungan staf	Spread sheet	Sesuai SDM	Rekrutmen	
	b) Melaksanakan Orientasi khusus bagi staf baru	1. Melakukan supervisi SPO unit yang telah di berikan 2. Melakukan penilaian tindakan yang telah dilakukan	Lembar penilaian staf orientasi	Spread sheet	Sesuai SDM	Laporan Penilaian Staf Orientasi	
	c) Membuat penilaian Kinerja staf	Melakukan pencatatan penilaian kinerja staf	Lembar Penilaian Kinerja	Spread sheet	Sebulan sekali	Laporan Penilaian Kinerja	
	d) Melaksanakan Diklat terkait akreditasi (mengikuti SDM)	1. Membuat usulan ke SDM kebutuhan Diklat 1 th 2. Melaksanakan panggilan Diklat	Pelatihan/ diklat	Mengisi Form di SIMRS	Sesuai SDM	Sertifikat	
	e) Melaksanakan Diklat NICU (mengirimkan 1-2 staf ke RSSA atau RSUD dr. Soetomo)		Seluruh staff	Eksternal	100%	sertifikat	
2	Melaksanakan Asuhan pasien NICU						
	a) Melakukan Personal Higiene	Melakukan seka tiap hari	SOP Personal Hygiene	Pasien	Setiap hari	CPPT	
	b) Melakukan Asuhan Pasien	Melakukan asuhan pasien sesuai dengan kebutuhan pasien	SOP	Pasien	Setiap hari	CPPT	



	c) Melakukan Tindakan Kegawatan NICU	Melakukan asuhan pasien sesuai dengan kegawatan pasien	SOP	Pasien	Setiap hari	CPPT	
	d) Melakukan Pemberdayaan Keluarga Pasien	Melakukan edukasi ke keluarga pasien	Leaflet	Keluarga pasien	Setiap hari	Form Edukasi	
	e) Melakukan Pelayanan Psiko, Sosio, Cultural, Spiritual	Melakukan pelayanan kepada pasien untuk spiritual	RPR	Keluarga pasien	2x/minggu	Form RPR	
3.	Pengembangan Pelayanan						
	c. Ruang tunggu khusus keluarga pasien NICU	Melakukan koordinasi dengan Kabid Pelayanan dan Kabid Umum	Form Pengajuan	Internal	Terpenuhi	Adanya fasilitas ruang tunggu yang nyaman khusus untuk keluarga pasien ICU	
	d. Penambahan aksesoris foto dan studio foto baby newborn	Melakukan koordinasi dengan Kabid Pelayanan dan Kabid Umum	Form Pengajuan	Internal	Terpenuhi	Adanya fasilitas ruang tunggu yang nyaman khusus untuk keluarga pasien ICU	
4	Melaksanakan MFK-K3						
	e. Melaksanakan Pemeliharaan sarana NICU (Bangunan)	Koordinasi dengan IPSRS dan PJ Alat Medis	Supervise	Lembar ceklist	Untuk pemeliharaan dilakukan selama 1 bulan sekali	Hasil supervise Laporan	
	Melaksanakan Pemeliharaan Prasarana ICU (pemeliharaan harian aldok/alkes/ Kalibrasi f. aldok/alkes	Koordinasi dengan IPSRS dan PJ Alat Medis	Supervise	Lembar ceklist	Untuk pemeliharaan dilakukan selama 1 bulan sekali dan kalibrasi dilakukan selama 1 tahun sekali	Hasil supervise Laporan	
	g. Melaksanakan Penambahan alat baru	Koordinasi dengan Karu, Kabid untuk pengadaan	Form Pengadaan	Form Pengajuan	Sesuai kebutuhan	Adanya alat baru	



		alat baru	alat baru				
	h. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja c) Melakukan pencegahan/mitigasi risiko terjadinya Kecelakaan kerja (paparan, paparan, tusukan, terpeleset, d) Melakukan MCU	c) Koordinasi dengan Komite K3 dan PIC Unit	a) Supervise b) Form MCU	a) Lembar ceklist b) Poli MCU	b) Setiap hari Setiap 1 tahun sekali	b) Hasil supervise • Laporan hasil MCU	
5	Melaksanakan Pengukuran Indikator Mutu yang diukur di N I C U (PMKP)						
	a. Pengukuran Indikator Mutu Nasional (NIM) 1) Kepatuhan Identifikasi Pasien 2) Kepatuhan Kebersihan Tangan 3) Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Jatuh 4) Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri 5) Kepatuhan Waktu Visite Dokter ≤ 14:00 WIB 6) Kepatuhan perawat terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR	Koordinasi dan melakukan supervisi terkait mutu INM	Supervisi	Spread sheet SIMRS	Dilakukan penginputan oleh Pulta setiap hari dan di validasi oleh Karu setiap hari	1. Laporan 2. Supervisi	
	b. Pengukuran Indikator Mutu Prioritas Unit: 1) Kejadian tidak dilakukan IMD pada bayi baru lahir	Koordinasi dan melakukan supervisi terkait mutu SKP	Supervisi	Spread sheet SIMRS	Dilakukan penginputan oleh Pulta setiap hari dan di	1. Laporan 2. Supervisi	



	2) Kepatuhan Petugas dalam melakukan Tindakan Ventilasi Tekanan Positif (VTP) pada bayi baru lahir tanpa ada usaha napas (< 1 menit) 3) Bayi baru lahir yang mengalami sesak napas yang mendapatkan T-Piece resuscitator/ CPAP dalam waktu 2 menit 4) Bayi baru lahir hidup stabil berat lahir 1500-2000 gr yang mendapatkan perawatan metode kangguru (PMK) minimal 1 jam per hari 5) Kepatuhan DPJP dalam pemberian antibiotic pada BBL infeksi 6) Kejadian Kematian Bayi di Rumah Sakit 7) Kemampuan menangani BBLR 1500 gr – 2500 gr				validasi oleh Karu setiap hari		
6	Melaksanakan program PPI di NICU						
	1. Melaksanakan Kewaspadaan standard i) Hand Hygiene j) Alat Pelindung diri	Koodinasi dan melakukan supervisi terkait PPI	Supervisi	Spread sheet	Setiap hari	Laporan	



	k) Pemilahan sampah l) Kejadian Plebitis m) Kejadian Bundle ISK n) Presentase Bundle ISK o) Kejadian Bundle VAP p) Kejadian Dekubitus						
	2. Melaksanakan Kewaspadaan Transmisi	Koodinasi dan melakukan supervisi terkait PPI	Supervisi	Spread sheet	Setiap hari	Laporan	
7	Melaksanakan Program PKRS						
	1. Melaksanakan KIE kepada pasien dan keluarga	Melakukan edukasi setiap hari kepada pasien dan keluarga	3) Form Edukasi	SIMRS	Setiap hari	Form kebutuhan edukasi	
	2. Melaksanakan KIE kepada pengunjung/kelompok (8x/bl)	Melakukan edukasi kepada penunjang kelompok	3) Leaflet	Link Laporan Edukasi	8x/bulan	Form Edukasi Kelompok	
	3. Melaksanakan KIE Kepada Masyarakat (Massa melalui radio Rs, Media Sosial)	Melakukan Edukasi kepada Masyarakat	3) Radio RS	Laporan	1x/bulan	Form Edukasi	
	4. Mengelola logistik & Media Edukasi untuk R. NICU	Melakukan pengelolaan media edukasi	3) Form Pengadaan	Form	1x/bulan	Adanya Media Edukasi	
8	Melaksanakan MONEV						
	Melaksanakan Monitoring (Supervisi) dan Evaluasi semua program g) Asuhan pasien h) MFK-K3 i) PMKP j) PPI k) PKRS l) Manrisk	Melakukan monitoring supervisi dan evaluasi	Supervisi Evaluasi	Spread sheet	1) Setiap hari 1x/bulan	1) Setiap hari 1x/bulan	
	Melaksanakan Rapat Unit	Melakukan rapat unit	Umandok	Laporan	1x/bulan	Setiap 1 bulan sekali	



	Menghadiri Rapat Koordinasi antar unit, manajemen program	Melakukan rapat koordinasi antar unit, manajemen, program	Umandok	Laporan	1x/bulan	Setiap 1 bulan sekali	
9	Membuat laporan						
	Membuat laporan bulanan (bulanan, tahunan)	Melakukan pembuatan laporan bulanan dan laporan tahunan	Laporan	Laporan	1 bulan sekali dan satu tahun sekali	Laporan bulanan dan laporan tahunan	

3.4. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2026

Tabel 3.4 Jadwal Pelaksanaan disesuaikan jadwal di atas

No	Kegiatan	Sasaran	Bulan												Tempat	PIC	Sumber Dana	Ket
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1.	Meningkatkan SDM ICU																	
1)	Menghitung Kebutuhan SDM	1. SDM 2. Staff NICU													NICU	Karu	PT.DPM	
2)	Melaksanakan Orientasi khusus bagi staf baru		Sesuai SDM												NICU	Karu	PT.DPM	
3)	Membuat penilaian Kinerja staf														NICU	Karu	RS	
4)	Melaksanakan Diklat terkait akreditasi (mengikuti SDM)														R. Diklat	SDM	PT.DPM	
5)	Melaksanakan Diklat ICU (mengirimkan 2 staf ke RSSA)														RSSA/ RSUD Dr. Soetomo	SDM	PT.DPM	
2	Melaksanakan Asuhan pasien-pasien ICU																	
1)	Melakukan Personal Higiene	Seluruh pasien pasien NICU													R. NICU	Seluruh Staf NICU	RS	
2)	Melakukan Asuhan Pasien	Seluruh pasien pasien NICU																
3)	Melakukan Tindakan Kegawatan di ICU	Seluruh pasien pasien NICU																
4)	Melakukan Pemberdayaan Keluarga Pasien	Seluruh keluarga pasien NICU																
5)	Melakukan Pelayanan Psiko, Culturo Spiritual	Seluruh pasien pasien NICU																
3	Pengembangan Pelayanan																	
1)	Ruang tunggu Khusus Keluarga pasien NICU dilengkapi dengan speaker portable	Penunggu pasien NICU													R. Tunggu NICU	Kabid Pelayanan Kabid	PT.DPM	



																	Umum		
4	Melaksanakan MFK-K3																		
1)	Melaksanakan Pemeliharaan sarana NICU (Bangunan)	Tukang															R. NICU	Karu NICU Kabid Umum	PT.DPM
2)	Melaksanakan Pemeliharaan Prasarana NICU (pemeliharaan harian aldok/alkes/ Kalibrasi aldok/alkes	IPSRS Pihak Ketiga															R. NICU	PIC Alat Unit Kabid Umum	RS
3)	Melaksanakan Penambahan alat baru	IPSRS Gudang Farmasi															R.NICU	IPSRS Pengadaaan PT	RS
4)	Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja a) Melakukan pencegahan/mitigasi risiko terjadinya Kecelakaan kerja (paparan, paparan, tusukan, terpeleset, jatuh, kesetrum) b) Melakukan MCU	Seluruh staf NICU															R.NICU	PIC K3RS Komite K3RS	RS
5	Melaksanakan Pengukuran Indikator Mutu yang diukur di N ICU (PMKP)																		
1)	Pengukuran Indikator Mutu Nasional (NIM) 1) Kepatuhan Identifikasi Pasien 2) Kepatuhan Kebersihan Tangan 3) Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Jatuh 4) Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	Koordinasi dan melakukan supervisi terkait mutu INM															R.NICU	PIC Mutu Komite Mutu	RS



	5) Kepatuhan Waktu Visite Dokter $\leq$ 14:00 WIB 6) Kepatuhan perawat terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR																	
2)	Pengukuran Indikator Mutu Prioritas Unit: 1) Kejadian tidak dilakukan IMD pada bayi baru lahir 2) Kepatuhan Petugas dalam melakukan Tindakan Ventilasi Tekanan Positif (VTP) pada bayi baru lahir tanpa ada usaha napas (< 1 menit) 3) Bayi baru lahir yang mengalami sesak napas yang mendapatkan T-Piece resuscitator/ CPAP dalam waktu 2 menit 4) Bayi baru lahir hidup stabil berat lahir 1500-2000 gr yang mendapatkan perawatan metode kangguru (PMK) minimal 1 jam per hari 5) Kepatuhan DPJP dalam pemberian antibiotic pada BBL infeksi	Koordinasi dan melakukan supervisi terkait mutu SKP													R.NICU	PIC Mutu Komite Mutu	RS	



	6) Kejadian Kematian Bayi di Rumah Sakit 7) Kemampuan menangani BBLR 1500 gr – 2500 gr																		
6	Melaksanakan program PPI di ICU																		
1)	Melaksanakan Kewaspadaan standard a) Hand Hygiene b) Alat Pelindung diri c) Pemilahan sampah d) Kejadian Plebitis e) Kejadian Bundle ISK f) Presentase Bundle ISK g) Kejadian Bundle VAP h) Kejadian Dekubitus	Seluruh staf NICU															R.NICU	PIC PPI Komite PPI	RS
2)	Melaksanakan Kewaspadaan Transmisi	Seluruh staf NICU															R.NICU	PIC PPI Komite PPI	RS
7	Melaksanakan program PKRS																		
1)	Melaksanakan KIE kepada pasien dan keluarga	Seluruh pasien dan keluarga NICU															R. NICU	PIC PKRS Komite PKRS	RS
2)	Melaksanakan KIE kepada pengunjung/kelompok (8x/bl)	Seluruh keluarga pasien NICU															R. NICU	PIC PKRS Komite PKRS	RS
3)	Melaksanakan KIE Kepada Masyarakat (Massa melalui radio Rs, Media Sosial)	Seluruh keluarga pasien NICU															R. NICU	PIC PKRS Komite PKRS	RS
4)	Mengelola logistik & Media Edukasi untuk R. ICU	Seluruh keluarga pasien NICU															R. NICU	PIC PKRS Komite PKRS	RS
8	Melaksanakan MONEV																		
1)	Melaksanakan Monitoring (Supervisi) dan Evaluasi semua	Kepala Ruang NICU															R.NICU	Karu NICU	RS



	program a) Asuhan pasien b) MFK-K3 c) PMKP d) PPI e) PKRS Manrisk																	
2)	Melaksanakan Rapat Unit	Kepala Ruang NICU													R.NICU	Karu NICU	RS	
3)	Menghadiri Rapat Koordinasi antar unit, manajemen, program	Kepala Ruang NICU													R.NICU	Karu NICU	RS	
9	Membuat Laporan																	
1)	Membuat laporan bulanan (bulanan, tahunan)	Kepala Ruang NICU													R.NICU	Karu NICU	RS	

3.5. Kebutuhan Anggaran

Semua anggaran akan dibiayai dari anggaran RS Prima Husada Sukorejo yang telah disetujui oleh PT.DPM dengan rincian sebagaimana terlampir:

Tabel 3.5 Kebutuhan Anggaran ALat Unit

No	Kebutuhan	Stok Unit	Pengajuan	Rata ² /Bulan	Harga @Alat	Total (Rp)
1.	Low Flow Neonatus	0	3	60x/ bulan	Rp. 1.500.000	Rp. 4.500.000
					Total	Rp. 4.500.000

Tabel 3.6 Kebutuhan Anggaran Diklat Unit

NO	Kegiatan	Internal eksternal	Jumlah (satuan)	HARGA SATUAN	TOTAL Rp
1.	Pelatihan Internal tentang pelayanan Neonatus	Internal	9 orang	Rp. 100.000	Rp. 900.000
2.	Manajemen BBLR	Eksternal	3 orang	Rp. 3.500.000	Rp. 10.500.000
3.	Resusitasi Neonatus	Eksternal	3 orang	Rp. 6.500.000	Rp. 19.500.000
4.	Pelatihan Dasar NICU	Eksternal	2 orang	Rp. 15.000.000	Rp. 30.000.000
				Total	Rp. 60.900.000

Tabel 3.7 Kebutuhan Anggaran Pengembangan Pelayanan

NO	Kegiatan	Internal eksternal	Jumlah (satuan)	HARGA SATUAN	TOTAL Rp
1.	Bean Bag Newborn	Eksternal	1	Rp. 700.000	Rp. 700.000
2.	Alas/ Backdrop Fabric	Eksternal	3	Rp. 100.000	Rp. 300.000
3.	Wrap/ Swaddle	Eksternal	4	Rp. 75.000	Rp. 300.000
4.	Aksesori sederhana (topi/ bando)	Eksternal	6	Rp. 40.000	Rp. 240.000
5.	Bantal kecil pose newborn	Eksternal	2	Rp. 50.000	Rp. 100.000
6.	Karpet lembut kecil	Eksternal	1	Rp. 200.000	Rp. 200.000
7.	Portable White Noise Baby Machine	Eksternal	1	Rp. 300.000	Rp. 300.000
8.	Pemanas Ruangan Mini	Eksternal	1	Rp. 300.000	Rp. 300.000
				Total	Rp. 2.440.000



BAB IV. MONITORING DAN EVALUASI

Jadwal kegiatan tersebut akan dimonitoring dan dievaluasi setiap satu bulan sekali, sehingga bila dari evaluasi diketahui ada pergeseran/ penyimpangan jadwal dapat segera diperbaiki sehingga tidak mengganggu program secara keseluruhan. Evaluasi skedul (jadwal) kegiatan tersebut dilakukan oleh kepala instalasi.



BAB V.

PENCATATAN DAN PELAPORAN

Jadwal kegiatan tersebut akan dievaluasi setiap satu bulan sekali, sehingga bila dari evaluasi diketahui ada pergeseran/penyimpangan jadwal dapat segera diperbaiki sehingga tidak mengganggu program secara keseluruhan. Evaluasi jadwal kegiatan tersebut dilakukan oleh kepala instalasi rawat inap Rumah Sakit Prima Husada.

Laporan evaluasi jadwal kegiatan dibuat setiap satu tahun sekali, dibuat dalam bentuk laporan dan ditujukan kepada Direktur RS Prima Husada



BAB VI

PENUTUP

Demikian program kerja unit NICU disusun dan disampaikan sebagai acuan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan di RS Prima Husada Sukorejo tahun 2026. Segala dukungan dan kerjasama yang diberikan dapat menunjang terlaksananya program kerja yang sudah disusun.

Mengetahui

Pasuruan, 21 November 2025

Kepala Instalasi / Pejabat di atasnya

Kepala Ruang / Instalasi

dr. Ratih Kusumawardhani, Sp. A

Ns. Ayu Mayang Priningtiyas, S. Kep

Menyetujui,

Direktur RS Prima Husada Sukorejo



Heni Indra Wulandari, S. Kep., Ns., M. Kep